

Życie na cienkim lodzie

Życie z osobą uzależnioną to chroniczny stres, którego skutki przypominają zespół stresu pourazowego. Twoje reakcje nie są nadwrażliwością — są odpowiedzią na nieprzewidywalne otoczenie.

CZAS: 15 min Psychoedukacja partnerstwa

ŹRÓDŁO: Orford i wsp. (2005); Roberts & Bhui (2007); Stanton (2004)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **cztery wymiary traumy relacyjnej**, które typowo występują u partnera osoby uzależnionej. Sekcja 02 — **walidacja**: dlaczego te reakcje to nie nadwrażliwość, tylko adaptacja. Sekcja 03 — pytanie o własną tożsamość poza relacją. Sekcja 04 — kierunki pracy nad sobą, *niezależnie od tego, czy partner się leczy*.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Życie z osobą uzależnioną jest dziś rozpoznawane w literaturze klinicznej jako *trauma relacyjna* (Roberts & Bhui, 2007; Orford, 2005). Mechanizm: chroniczna nieprzewidywalność, wielokrotne łamanie obietnic, powtarzane kryzysy, doświadczanie zachowań osoby pod wpływem (czasem agresji, czasem absencji emocjonalnej). U partnera typowo rozwijają się objawy *przypominające PTSD*: czujność, intruzje, unikanie, drętwienie emocjonalne. Często są też depresja i objawy somatyczne. Orford i wsp. (2005, badanie w 3 krajach, N>1500 bliskich): partnerzy osób uzależnionych mają **2-3x wyższy** wskaźnik problemów zdrowia psychicznego niż populacja ogólna. To ma znaczenie kliniczne: **partner też wymaga leczenia** — i nie musi czekać, aż osoba uzależniona podejmie terapię, żeby zacząć dbać o siebie. *Paradoks kliniczny*: wielu partnerów „rozsypuje się” dopiero, gdy partner zaczyna trzeźwieć — bo walka z piciem przestaje kryć własny ból.

01 Cztery wymiary traumy relacyjnej

1 · CZUJNOŚĆ

Nasłuchiwanie kroków, sprawdzanie oddechu, wąchanie ubrań, kontrola telefonu, sprawdzanie konta. Mózg **stałe skanuje** sygnały zagrożenia. To nie obsesja — to wytrenowana adaptacja.

2 · INTRUZJE

Powracające obrazy z awantur, ciągów, kryzysów. Sny, w których powtarza się ta sama scena. Reakcje na *wyzwalacze* — zapach alkoholu, brzęk butelek, ton głosu — silniejsze niż wydaje się otoczeniu.

3 · UNIKANIE

Tematów, miejsc, ludzi, którzy mogą wywołać awanturę. Wieczornych wyjść (bo wracać do nieprzewidywalnego domu jest gorzej niż nie iść). Spotkań rodzinnych. Z czasem życie się **zwęża**.

4 · DRĘTWIENIE EMOCJONALNE

„Już *nic nie czuję*”. Spadek radości, spadek smutku, spadek wszystkiego. To **chronicznie utrzymywane wyłączenie** emocji — sposób, którym mózg chroni przed bólem zbyt długim, by go znieść.

Te objawy **nie muszą** oznaczać klinicznego PTSD — wymagają tego oceny przez specjalistę. Ale są **realne**, mają mechanizm, mają nazwę, i są uleczalne.

02 Walidacja — to nie nadwrażliwość, to adaptacja

Często słyszysz: „przesadzasz”, „uspokój się”, „nie rób z tego tragedii”. Czasem mówi to partner, czasem rodzina, czasem własna głowa. To zdania, które *dodatkowo* rozłączają od własnego doświadczenia. Trzy fakty kliniczne, które warto znać.

FAKT 1 · ADAPTACJA, NIE WADA

Czułość, kontrola i wycofanie to *logiczne odpowiedzi* na nieprzewidywalne otoczenie. Twój mózg robił *dokładnie to, do czego jest zaprojektowany*: chronił Cię.

FAKT 2 · LICZBY

Orford i wsp. (2005): bliscy osób uzależnionych mają **2-3x wyższy** wskaźnik depresji, lęku i objawów somatycznych. To populacja klinicznie ważna, nie marginalna.

FAKT 3 · NIEZALEŻNIE OD PARTNERA

Twoje leczenie *nie wymaga*, by partner najpierw przestał pić. Możesz korzystać z terapii indywidualnej, Al-Anon, leczenia farmakologicznego depresji — **od dziś**.

03 Kim jestem poza tą relacją

U wielu partnerów osób uzależnionych z czasem zaciera się tożsamość poza relacją. Życie kręci się wokół picia drugiego: *czy pił, kiedy pił, ile, co dalej*. Trzy pytania, do których wraca się w terapii — i które warto sobie zadać, nawet jeśli odpowiedzi nie przychodzą od razu.

CO LUBIŁEM/-AM ROBIĆ, ZANIM UZALEŻNIENIE PRZEJĘŁO WASZE WSPÓLNE ŻYCIE

— *rzeczy, do których chcę wrócić*

Z KIM UTRZYMYWAŁEM/-AM BLISKI KONTAKT 5–10 LAT TEMU, DO KOGO DZIŚ CHCĘ WRÓCIĆ

JAKIM CZŁOWIEKIEM CHCĘ BYĆ ZA PIĘĆ LAT

— *niezależnie od tego, co stanie się z relacją*

04 Trzy kierunki, niezależnie od decyzji o relacji

TERAPIA INDYWIDUALNA

Praca z hiperczułością, schematami, traumą relacyjną. Najczęściej skuteczne nurty: CBT, schematy, terapia traumy (np. EMDR).

WSPÓLNOTA

Al-Anon, grupy dla partnerów. Doświadczenie „*nie jestem sam/-a, ktoś tu przeżył to samo*” jest klinicznie znaczące.

CIAŁO I RUTYNA

Sen, ruch, jedzenie, regularność. Ciało zostaje obciążone tym, co nazywamy emocjami. Bez tego — żadna terapia nie wystarczy długoterminowo.

Klucz: Najtrudniejszy paradoks tej sytuacji: wielu partnerów *rozsypuje się dopiero wtedy, gdy partner zaczyna trzeźwieć*. Dotychczasowy „adrenalinowy” tryb funkcjonowania (kryzys → reakcja → kryzys) zostaje wyłączony, a *spod niego wyłania się* nieprzepracowany ból, smutek, gniew. To **nie znaczy, że trzeźwienie partnera szkodzi** — znaczy, że Ty potrzebujesz wsparcia *w tym właśnie momencie*, nie później. Stanton (2004): „Partnerstwo z osobą uzależnioną *nie jest cechą charakteru* partnera — jest *doświadczeniem*, które wymaga przeleczenia jak każde inne trudne doświadczenie.”